

Simulation orale des passages clés

Leçon probatoire HETS Genève · 5 juin 2026

Pierre Brasseur

SIMULATION ORALE — Passages clés à pratiquer

Trois passages décisifs où le cadrage corporel, la voix et le rythme font la différence. Texte mot-à-mot, balisé :
// = silence court (1 s), /// = silence long (2-3 s), [didascalies en italique]. À lire à voix haute trois fois avant la leçon.

PASSAGE 1 — Vignette d'ouverture (0-5 min)

[Vous arrivez devant la salle. Le silence n'est pas encore complet. Vous attendez que tout le monde se taise. Pas avant.]

[Voix posée, regard parcourant la salle, lentement.]

Bonjour à toutes et à tous. // Merci de me recevoir aujourd'hui pour cette séance du module *Handicap, autonomie et travail social*.

[Silence court. Vous regardez le projecteur, vous changez de slide vers la slide 3 — la vignette de Léa.]

Je voudrais commencer par une situation. /// Pas un cas clinique, pas une étude de cas — une situation, telle qu'elle peut arriver dans l'une de vos formations pratiques, demain.

[Vous lisez la vignette à voix haute, lentement. Marquer la pause après chaque phrase.]

Léa, vingt-deux ans, a une trisomie 21. // Elle vit à L'Atelier, un dispositif d'accompagnement des jeunes adultes de quinze à dix-huit ans, géré par la Fondation Ensemble, à Genève. /// Un matin, en réunion d'équipe, son éducatrice référente rapporte une demande. // Léa a dit ceci :

[Vous prenez le temps. Vous regardez la slide. Vous laissez la phrase s'installer.]

« Je veux un appartement à moi // et un amoureux qui dort là. »

[Long silence — au moins trois secondes.]

La mère de Léa, qui vient chaque week-end, demande à l'équipe de « la raisonner ».

[Silence. Vous regardez la salle.]

Voilà la situation. /// Je vais vous demander, dans quelques instants, ce que vous feriez, vous. Mais avant, je voudrais qu'on prenne le temps d'identifier ce qui se joue dans cette demande.

[Transition vers le plan, slide 2.]

Cette séance va se construire en quatre temps. // D'abord les modèles théoriques du handicap, ces grammaires qui structurent — souvent à notre insu — notre regard de professionnel·le. // Ensuite les transformations contemporaines du champ, à l'échelle suisse, et à l'échelle genevoise. // Puis trois tensions de posture, qui sont, à mon avis, ce que vous allez rencontrer le plus souvent dans votre pratique. // Et enfin, nous reviendrons à Léa.

[Posture d'engagement. Voix qui descend légèrement, ferme.]

À la fin de cette séance, vous saurez quoi dire à Léa, à sa mère, et à l'équipe. // Ou plus exactement, vous saurez **comment** construire ce que vous direz, à partir des outils qu'on aura travaillés.

[Transition vers la slide 4, le lexique. Le rythme s'accélère légèrement.]

PASSAGE 2 — Articulation des trois tensions (29-33 min)

[Vous arrivez après la troisième micro-interaction. Vous avez listé les transformations. Le rythme a été soutenu sur les dix dernières minutes. Vous ralentissez.]

Bien. /// On vient de voir les transformations qui traversent le champ.

[Vous changez de slide vers slide 12 — Tension 1.]

Maintenant je voudrais qu'on regarde **ce que ces transformations font à la posture professionnelle**. // Parce qu'elles n'arrivent pas dans le vide. Elles arrivent dans des équipes, dans des situations, dans des dilemmes. /// Je vais vous proposer trois tensions. // Pas pour vous démoraliser. // Pour vous outiller.

[Posture critique mais chaleureuse. Voix de quelqu'un qui partage une difficulté, pas qui sermonne.]

Tension numéro un — Protection et autonomie.

En mille neuf cent soixante-douze, un éducateur américain, Robert Perske, écrit une phrase qui va devenir un acquis fondamental du champ. // Il dit ceci : « *Surprotéger les personnes handicapées, c'est nier leur humanité. Il faut leur restituer le droit au risque ordinaire.* »

[Silence. Vous regardez la salle.]

Le droit au risque ordinaire. /// Pensez à ce que vous faisiez à vingt ans. Vos erreurs, vos rencontres maladroites, vos décisions un peu trop rapides. // Tout ça, c'est ce qu'on appelle vivre. C'est ce que Léa réclame. // Et ce que la mère de Léa, par amour, voudrait lui éviter.

La CDPH, dans son article douze, fait passer un seuil. Du paradigme de la substitution de décision — « *on décide à votre place pour vous protéger* » — au paradigme du soutien — « *on vous aide à décider, vous* ». // Et c'est l'éthique du care, chez Tronto, chez Paperman et Laugier, qui nous donne le vocabulaire pour penser ça : le care comme attention située, pas comme protocole.

[Transition rapide vers slide 13 — Tension 2.]

Tension numéro deux — Expertise professionnelle et savoir expérientiel.

Le mouvement des disability studies a un slogan, qui date de mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et qui résume tout : « *Nothing about us without us.* » // Rien sur nous sans nous.

[Vous attendez. Vous regardez si l'auditoire suit.]

Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le savoir construit dans l'expérience de la situation a une légitimité propre. // Pas inférieure à la nôtre, pas supérieure à la nôtre. // Différente. // Et complémentaire.

La pair-aidance, c'est l'institutionnalisation professionnelle de cette idée. // Mais attention : co-construire un projet d'accompagnement avec une personne concernée sans la réduire à un témoin — c'est plus difficile qu'il n'y paraît. C'est ce que j'ai documenté dans un article que j'ai écrit avec Jacques Rodriguez, en deux mille dix-neuf, sur les mobilisations pour le droit à l'intimité. // Trop souvent, « *les handicapés témoignent et les valides expertisent* ».

[Posture critique. Vous tenez le slogan dans la main.]

Cette division du travail, vous la rencontrerez. // À vous de la déjouer.

[Transition vers slide 14 — Tension 3.]

Tension numéro trois — Travail prescrit et travail réel.

C'est, pour moi, la tension la plus structurante du métier de travailleur social. // Yves Clot, en mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, dans un livre qui s'appelle *La fonction psychologique du travail*, pose une distinction qui va devenir centrale en clinique de l'activité. // D'un côté, le travail prescrit : la fiche de poste, le référentiel d'activité, les procédures institutionnelles, les contraintes du financement. // De l'autre, le travail réel : ce que la situation, à cet instant, dans cette pièce, avec cette personne, exige réellement de vous.

Ces deux travaux ne sont jamais identiques. /// Clot dit même que la souffrance professionnelle vient du « *travail empêché* » — du travail bien fait qu'on n'a pas pu faire. // Pour un éducateur, c'est : « *J'aurais voulu prendre vingt minutes avec elle, mais j'ai dû finir les transmissions.* » Pour une assistante sociale, c'est : « *J'aurais voulu l'orienter vers ce dispositif, mais l'institution ne le reconnaît pas.* »

Michael Lipsky, en mille neuf cent quatre-vingts, dans un livre fondateur — *Street-Level Bureaucracy* — théorise quelque chose de très proche : il dit que les agents de première ligne, dont vous ferez partie, ne sont pas seulement des exécutants. Ils sont des **producteurs de politique publique**. // Au guichet. // Dans le bureau. // Dans la chambre du résident. // Par chaque décision discrétionnaire qu'ils prennent.

[Vous montrez la slide 14, vous pointez la troisième ligne.]

Et en deux mille vingt-cinq, Catherine Lenzi — qui enseigne ici — et Alexandre Moine, publient un ouvrage chez Champ social qui s'appelle *Des pas de côté dans le travail social*. // Ils mobilisent la notion d'**autonomie discrétionnaire**. C'est-à-dire la marge de manœuvre que vous avez, dans chaque situation, pour faire **autrement** que ce que prescrit la procédure. // Cette marge, ce n'est pas une déviance. C'est la condition même de l'éthique professionnelle.

[Posture conclusive. Vous balayez la salle du regard.]

Vous serez en tension. // C'est normal. // C'est même le signe que vous travaillez bien.

[Transition vers slide 15 — Activité interactive. Le rythme change.]

PASSAGE 3 — Clôture (38-40 min)

[Vous venez de recueillir les trois restitutions du think-pair-share. L'énergie de la salle est là. Vous ne la cassez pas. Vous l'orientez.]

Très bien. /// Ce que vous venez de faire, en cinq minutes, c'est exactement ce qu'on vous demandera de faire en équipe pluridisciplinaire, dans votre vie professionnelle. // Mobiliser un concept du cours pour argumenter une posture. // Pas une opinion, pas une intuition. /// Une **posture argumentée**.

[Vous changez de slide vers slide 16 — les 3 acquis.]

Si je devais résumer cette séance en trois acquis, ce serait ceux-ci.

[Vous lisez la slide en marquant chaque numéro.]

Un. Les modèles du handicap ne sont pas des étapes successives. // Ils coexistent dans chaque institution comme des **grammaires actives**. Reconnaître le modèle dominant d'une institution, c'est déjà commencer à y intervenir.

Deux. Les transformations suisses — la CDPH, la contribution d'assistance, l'Initiative pour l'inclusion, le plan cantonal genevois, l'avant-projet LED-H — ouvrent des **marges concrètes** pour les travailleur·ses sociaux·ales. Ce ne sont pas des décors lointains. Ce sont des outils que vous mobiliserez, dès vos formations pratiques.

Trois. La posture professionnelle n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas une qualité personnelle qu'on aurait ou pas. // C'est un **travail réflexif quotidien** sur trois tensions structurelles. Et ce travail, il s'apprend.

[Vous changez de slide vers slide 17 — lectures et ouverture.]

Pour aller plus loin, je vous renvoie à trois ouvrages. // Ville, Fillion et Ravaud, *Introduction à la sociologie du handicap*, De Boeck — c'est le texte-support du module. // Les travaux de Manon Masse et de son équipe sur la mise en œuvre de la CDPH en Romandie, accessibles en libre accès sur OpenEdition. // Et l'ouvrage tout récent de Catherine Lenzi et Alexandre Moine que je viens de citer, *Des pas de côté dans le travail social*, paru chez Champ social en deux mille vingt-cinq.

[Posture d'ouverture. Vous regardez la salle.]

La séance prochaine, on travaillera sur **le travail avec les proches**. // Entre alliés, opposants, et co-aidants. // La mère de Léa nous y accompagne. // Je vous demanderai d'apporter une situation rencontrée en formation pratique où la famille vous a déstabilisé·e — sans noms, sans lieu identifiable.

[Silence. Vous changez de slide vers la slide 18.]

Merci de votre attention. /// Je suis preneur de vos questions, de vos remarques, de vos désaccords.

[Vous posez votre clicker. Vous regardez la commission. Vous attendez.]

CONSEILS DE TRAVAIL DE LA VOIX

Avant la séance, dans la salle vide

1. Lire à voix haute le **passage 1** trois fois — c'est lui qui pose le ton.
2. Pratiquer le **silence après la phrase de Léa** — au moins 3 secondes, c'est très long quand on est seul·e en face de la salle.
3. Pratiquer la **transition entre tension 2 et tension 3** — c'est le moment où le rythme peut décrocher.
4. Lire la **clôture** à voix haute en regardant un point fixe — c'est le moment où le regard doit balayer la salle, pas le sol.

Pendant la séance

- Respirer trois fois lentement avant de commencer à parler.
- Boire une gorgée d'eau entre tensions 2 et 3.
- Si vous perdez le fil, ce n'est pas grave : dire « *Je reprends.* » et regarder votre slide.
- Si on rit dans la salle (sur la phrase de Léa par exemple), ne rien dire. Laisser passer. Reprendre.

Posture corporelle

- **Slide 3** (vignette) : immobile, debout, mains croisées devant.
- **Slides 5-8** (modèles) : marquer un pas latéral entre chaque modèle. Le corps dit ce que la pensée pose.
- **Slides 12-14** (tensions) : trois positions distinctes, légèrement décalées.
- **Slide 16** (acquis) : revenir au centre, ancré.
- **Slide 18** (merci) : un pas en avant, regard frontal, sourire bref.

Simulation orale v1 · Pierre Brasseur · À pratiquer trois fois avant le 5 juin.